

Presentación

*Pues la cuestión comienza
a partir de lo siguiente:
hay tipos de síntoma,
hay una clínica.
Sólo que es anterior al discurso analítico,
y si este le aporta una luz,
eso es seguro, pero no es certero.*

JACQUES LACAN, OTROS ESCRITOS (1973).

Hay una clínica, hay una psicopatología. Sólo que ninguna de las dos es "una". Ambas se constituyen como campos heterogéneos de saberes, atravesados por los efectos del tratamiento que históricamente se destinó a aquellos a los que se consideraba "locos"¹: el aislamiento, la segregación.

Este libro reivindica la importancia insoslayable de la escucha clínica en la práctica actual. El paradigma de la Salud Mental y los derechos humanos no debería dejar a un lado las diferencias típicas construidas por un trabajo colectivo, llevado a cabo durante dos siglos. Tampoco debería olvidarse que la psicopatología de la vida cotidiana está más extendida que el ideal armonioso e inalcanzable de la salud mental.

Los hombres sufren por el sólo hecho de tener una mente, de hablar. El malestar es su condición primera. Nada es más difícil de soportar que una sucesión de días felices.² El *pathos* no puede ser eliminado.

Este libro se propone como una contribución a la formación de las nuevas generaciones de psicólogos, quienes a partir de la sanción en Argentina de la Ley Nacional de Salud Mental N° 26657 han visto extendido su campo profesional a dominios que otrora eran exclusivos de las disciplinas médicas. Me refiero a las internaciones en salud mental, a la intervención en la urgencia, y al diagnóstico y tratamiento de las psicosis.

¹ Es importante aclarar que mantendremos durante todo el libro los apelativos propios de cada época para referirnos a aquellas personas a las que hoy llamaríamos usuarios en salud mental. Conservamos las denominaciones de "alienado", "insensato", "enfermo mental" y "paciente" como parte de la terminología en la que se pueden leer las concepciones vigentes en un momento histórico determinado. Rechazamos cualquier uso estigmatizante del vocabulario para referirse a las personas afectadas en su salud mental.

² Cita de Goethe, que Freud retoma en su artículo siempre actual "El malestar en la cultura". En S. Freud, *Obras completas*. Tomo XXI. Buenos Aires: Amorrortu editores, p. 76.

Es un trabajo orientado por las tesis del psicoanálisis acerca del padecimiento humano, pero que no por ello desdeña los aportes de la semiología psiquiátrica clásica y de las perspectivas fenomenológicas. Entendemos que la complejidad de los casos que recibimos requiere de las contribuciones de varias disciplinas. Una lectura de los síntomas es necesaria, como también lo es su organización a partir de una hipótesis psicopatológica y la escucha de la situación vital y social en su conjunto.

Este libro es también una invitación a que un trabajo de elaboración en conjunto con otros profesionales pueda producirse: en una escucha de las diferencias, un respeto por las incumbencias de cada disciplina y con una iniciativa abierta al diálogo. Es entonces una apuesta a la interdisciplina, un intento de aportar a la construcción de lenguajes posibles entre disciplinas de tradiciones tan distintas, entendiendo que “La interdisciplinareidad es un posicionamiento, no una teoría unívoca. Ese posicionamiento obliga básicamente a reconocer la incompletud de las herramientas de cada disciplina. (...) La actividad interdisciplinaria, sea de la índole que sea, se inscribe en la acción cooperativa de los sujetos, requiere de ello.” (Stolkiner, 2005: 5).

La apuesta a la interdisciplina es hoy un enunciado políticamente correcto, aunque su mera enunciación deje percibir inmediatamente la dificultad de tal empresa y la facilidad con la que se retorna a la seguridad de la parroquia conocida, ante el surgimiento del primer desacuerdo. Sólo para comprobar que ninguna de las disciplinas que intervienen en el campo de la salud mental están en condiciones de ofrecer ni siquiera un mínimo atisbo de solución a los problemas que se le dirigen:

La interdisciplina nace, para ser exactos, de la incontrolable indisciplina de los problemas que se nos presentan actualmente. De la dificultad de encasillarlos. Los problemas no se presentan como objetos, sino como demandas complejas y difusas que dan lugar a prácticas sociales invadas de contradicciones e imbricadas con cuerpos conceptuales diversos. (Stolkiner, 1987: 313).

La pluralidad y complejidad de los problemas que hoy recibimos requiere de un abordaje que permita, al menos, leer los obstáculos. Requiere de profesionales dispuestos y disponibles para el intercambio con otros, pero también demanda el respeto por las tradiciones disciplinares y las incumbencias profesionales. Y necesita de un lenguaje propicio para el diálogo.

El “lacanés” tanpreciado para algunos de nuestros jóvenes psicólogos no ha contribuido demasiado al trabajo en conjunto con médicos, psiquiatras, trabajadores sociales, enfermeros, terapistas ocupacionales y demás profesionales que intervienen en el campo de la salud mental. Eso no invalida la orientación subversiva que la teoría psicoanalítica le ha dado al tratamiento de las psicosis y que constituye la hoja de ruta de este libro.

Su organización está orientada por el trabajo de Freud y de Lacan, quienes reconocieron en el malestar humano presentaciones típicas que podían reconducirse a particulares posiciones subjetivas, cuyos rasgos comunes podían ser transmitidos, sin por eso eludir las singularidades. Me refiero a la tríada neurosis, psicosis, perversión. Hay tipos de síntomas particulares a cada una de esas formas de mal-estar en este mundo. Son esos tipos los que intentamos cer-

nir, revisitando los aportes de la psiquiatría clínica clásica y de la fenomenología a la configuración del extenso campo de las psicosis.

La tesis de la forclusión del Nombre-del-Padre y la estructura de la psicosis significó en la transmisión cierta dilución de las particularidades de los tipos clínicos de las psicosis. De alguna manera se convirtió en una especie de *revival* de la tesis de la psicosis única. Dejó de hablarse de *las* psicosis, en plural, para referirse a *la* psicosis, en singular. En este libro queremos recuperar esa pluralidad, seguramente más cercana a los últimos aportes de Lacan sobre los distintos tipos de anudamiento. Destinamos este tomo a la clínica de las psicosis - anudamientos y desanudamientos que no se referencian en el Nombre-del-Padre-, y anunciamos que está en preparación un segundo volumen destinado a los anudamientos de la *père-version*.

Pero ¿por qué volver a los clásicos de la psiquiatría en un libro orientado por el psicoanálisis? ¿Por qué leer a los clásicos? En primer lugar, porque el trabajo clínico de la psiquiatría clásica fue logrando cernir la existencia de tipicidades en la presentación de los síntomas: tipos de padecimientos con rasgos formales que pueden aislarse y que seguimos encontrando en nuestro trabajo de todos los días. Ese ha sido un primer principio de selección del material a incluir en este libro: hemos retomado las descripciones de los clásicos y de la fenomenología que resuenan con los problemas que hoy encontramos en la clínica.

De ahí que nos aventuremos a insistir a lo largo del libro en que son distinciones que están vigentes. El equipo de autores que ha trabajado en este libro se ha formado y es parte de los planteles profesionales de distintos hospitales y centros de salud de la ciudad de La Plata y de la provincia de Buenos Aires: Hospital A. Korn de Melchor Romero, HIGA Rossi, Policlínico San Martín, Hospital Esteves, Hospital Eva Perón y varios centros de salud. Muchos de ellos además son supervisores y docentes de residentes de otros hospitales de la región: Borda, Moyano, Álvarez, Alvear. Tenemos allí ocasión de comprobar lo indisciplinado de los problemas que se presentan, la necesidad del abordaje interdisciplinario y la actualidad de las distinciones clásicas. Son también docentes e investigadores en la universidad, animados por las preguntas que surgen en la transmisión de estos temas.

Lo que define a lo clásico es su vigencia, su actualidad. La potencia de los clásicos reside en que las preguntas que ellos pudieron hacerse en otro siglo siguen resonando en nuestra contemporaneidad y nos ayudan a leerla. Los debates y discusiones en el seno de la construcción de la clínica psiquiátrica clásica condujeron a formulaciones psicopatológicas absolutamente necesarias para la lectura de los problemas clínicos de hoy. En ese traqueteo intenso que intentaba delimitar y clasificar las distintas formas de patología mental se fueron configurando zonas de acuerdo, puntos de intersección, convergencias que nos interesan, en tanto leemos allí los tipos de síntomas que decantan, que logran cernirse, a pesar de que los supuestos que atraviesan esa observación clínica sean muy disímiles.

Es indudable que no puede afirmarse -sin caer en una concepción simplista y en un empirismo ingenuo- que la demencia precoz de Kraepelin sea lo mismo que la esquizofrenia de Bleuler. Ninguna observación es "pura." En el relato mismo de la descripción, muchas veces pretendidamente aséptica, se dejan ver las líneas de fuerza de los supuestos que la organizan.

Los supuestos y criterios de la mirada clínica de Kraepelin no son los mismos que aquellos de los que parte Bleuler.

Sin embargo, algo persiste y pasa a través de la trama de supuestos que organizan la observación. Esos rasgos que van pasando a través de los autores, en los que se puede leer un acuerdo tácito por el cual se los vincula a un tipo clínico y no a otro, son aquellos que nos interesa cernir y transmitir en este libro. Lacan (1966)³ llama a este método de trabajo "fidelidad a la envoltura formal del síntoma", y la define como el camino verdadero que puede abrir la clínica en la lectura del padecimiento (p. 60). Estas convergencias, estos puntos de acuerdo, esta constancia de ciertas invariantes, estos relieves comunes que trascienden y pasan a través de las distintas hipótesis de los clásicos son los que recogemos en este libro. Esas convergencias parecen dibujar un campo tripartito para el estudio de las psicosis, es el que vertebró a este libro: paranoias, melancolías y manías, esquizofrenias.

No podremos ofrecer aquí una lectura exhaustiva ni desentrañar la trama filosófica, epistemológica y política que inerva a la construcción de esta clínica. Nos contentaremos con apenas delinearla en los primeros capítulos e invitamos a los lectores interesados a remitirse a los autores que han profundizado en estos temas. Les dejamos indicada una red de referencias bibliográficas a las que podrán recurrir si esta primera aproximación los empuja a querer saber un poco más al respecto.

Valga la aclaración de que este libro no sustituye a la lectura de los clásicos, sino que sólo pretende ser una primera aproximación, un primer acercamiento, una invitación a su lectura, con la idea de poder entusiasmar a las jóvenes generaciones en su revisión. El esfuerzo de esta transmisión ha sacrificado seguramente desarrollos importantes de cada uno de los clásicos, pero se ha hecho en función de intentar superar las dificultades propias de la transmisión de una experiencia cuyo lenguaje técnico se gestó en el siglo XIX: dificultad mayor para nuestros estudiantes del siglo XXI.

En mi experiencia, el lenguaje de la clínica psiquiátrica clásica fue durante mi formación, y lo sigue siendo en mi práctica, el lenguaje posible del intercambio con mis colegas de otras disciplinas. Sin dudas le doy ese lugar de privilegio por encima de la propuesta del lenguaje común de los DSM, que no me resultó tan propicio al diálogo y del que en este libro se encontrará una visión crítica. Sigo considerando que la transmisión de esta clínica es fundamental en la formación. Es un conjunto de conocimientos que no se ahorra los vericuetos y las dificultades, ni intenta fragmentar el sufrimiento humano en categorías supuestamente más prácticas.

Este libro es una apuesta al diálogo entre disciplinas y es una contribución a sostener la importancia del método clínico en el tratamiento del sufrimiento humano. Es también un homenaje a aquellos que no retrocedieron en dar crédito a la palabra de los locos, tomarla al pie de la letra, convertirla en texto, devolverle su humanidad. Ojalá que en esta época de píldoras y prisa

³ El aparato de citas de este libro conserva entre paréntesis la notación del año de la primera edición en lengua original de la fuente citada, con el fin de facilitar al lector la referencia temporal del contexto de producción del conocimiento. En las referencias bibliográficas se encuentra la información completa sobre la edición utilizada.

vuelva a escucharse la palabra de esos "descarriados" y de esos psiquiatras que afrontaban la locura sin el alivio de los fármacos.

Por último, este libro es un intento de enseñar a escuchar las diferencias, porque sólo pudiendo reconocerlas quizás alentemos a respetarlas. Porque identificando las diferencias particulares estaremos más cerca de cernir las diferencias singulares, las máximas diferencias, las diferencias absolutas.

Julieta De Battista
La Plata, 2018

Referencias bibliográficas

- Freud, S. (1930). El malestar en la cultura. En S. Freud, *Obras completas*. Tomo XXI. Buenos Aires: Amorrortu editores, 1994, p. 57-140.
- Lacan, J. (1966). De nuestros antecedentes. En J. Lacan. *Escritos I*. Buenos Aires: Siglo XXI editores, 1988, p. 59-66.
- Lacan, J. (1973). Introducción a la edición alemana de un primer volumen de los *Escritos*. En J. Lacan, *Otros escritos*. Buenos Aires: Paidós, 2012, p. 579-585.
- Stolkiner, A. (1987). De interdisciplinas e indisciplinas. En N. Elichiry (Comp.) *El niño y la escuela. Reflexiones sobre lo obvio*. Buenos Aires: Ed. Nueva Visión, p. 313-315.
- Stolkiner, A. (2005). Interdisciplinariedad y salud mental. Conferencia en las X Jornadas nacionales de Salud Mental y I Jornadas provinciales de Psicología, Salud Mental y mundialización: estrategias posibles en la Argentina de hoy. Disponible en: www.psi.uba.ar/academica/...salud2/.../stolkiner_interdisciplina_salud_mental.pdf

PRIMERA PARTE

LA MEDICALIZACIÓN DE LA LOCURA MICROFÍSICA DEL PODER EN LA CREACIÓN DE LOS ASILOS

Julieta De Battista

Nicolás Campodónico

Mariana Dinamarca